Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo

Rua Bayard Toledo Mércio, 66 - Bairro: Canudos - CEP: 93548011 - Fone: (51) 3553-5500 - Email: frnovohamb3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008113-04.2021.8.21.0019/RS

AUTOR: JOSE ANTONIO FREITAS VALLE E SILVA PEZZI

RÉU: UNIMED VALE DO SINOS SOC COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que litigam as partes acima identificadas.

Alegou a parte autora ser beneficiária de plano de saúde administrado pela UNIMED VALE DO SINOS SOC COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA. Afirmou que padece de fibrose pulmonar idiopática CID 10 J84. 1 e doença pulmonar obstrutiva crônica CID J44 necessitando, para o tratamento da doença do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg. Asseverou a negativa da parte ré ao custeio desse medicamento, prescrito pelo médico assistente, em razão da exclusão contratual ao tratamento domiciliar. Apontou a nulidade dessa clausulas. Discorreu sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requereu a concessão de tutela de urgência, determinando-se o custeio do tratamento recomendado; ao final, seja tornada definitiva essa tutela.

Recebi a inicial, conforme segue:

RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo a inicial, porquanto satisfeitos, a princípio, os requisitos legais de admissibilidade.

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA E DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL

Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Civil de 2015, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Embora possível a concessão de moratória ou parcelamento em relação às despesas processuais em sentido amplo (taxa única, despesas em sentido estrito, honorários etc.), por força do disposto no § 6º do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015, é imprescindível, para tanto, que a parte comprove a impossibilidade de pagamento das despesas processuais no tempo oportuno.

No caso, as alegações da parte autorizariam o pagamento da taxa única de serviços judiciais parceladamente. ***Com efeito, é pinacular o o valor da taxa única (R$ 6.558,70 - simulação por mim realizada hoje no sistema eproc)1.***

A operacionalização desse pagamento, todavia, é, por ora, burocrática e custosa.

Por limitações dos sistemas informatizados, sequer é possível fornecer às partes todas as guias de pagamento de imediato, sendo necessária sua emissão mensal. Não bastasse isso, o valor de cada parcela, porque não fixada em reais, mas, sim, em unidades de referência de custas, varia periodicamente.

O resultado, nos processos em que deferido o parcelamento nesses moldes, não poderia ser outro, que não a instauração da barafunda processual, considerados os diversos requerimentos de expedição de guias - por e-mail e na secretaria desta unidade -, não pagamento dessas guias - que posteriormente têm de ser canceladas no sistema, pedidos de extinção do processo por abandono da causa em razão do atraso no pagamento das parcelas etc.

Nesse desolador cenário, o que se impõe, mais por pragmatismo, do que por razões jurídicas, ***é o pagamento das custas ao final.***

Observo, desde logo, que eventuais despesas em sentido estrito que tenham de ser suportadas pela parte autora ao longo da tramitação do feito, notadamente as de condução e honorários periciais, porque devidas a terceiros, não poderão ser pagas ao final, mas, sim, antecipadamente, nos termos do caput do artigo 82 do Código de Processo Civil de 2015.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, é densa a probabilidade do direito alegado na inicial.

Conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem "estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (AgRg no REsp 1.547.168/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016).

Com efeito, na ótica desse Tribunal é abusiva até mesmo a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. (AgInt no AREsp 1.573.008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

No caso em tela, a parte autora padece de gravíssimas enfermidades - ***fibrose pulmonar idiopática CID 10 J84. 1 e doença pulmonar obstrutiva crônica CID J44****.*

O médico assistente, credenciado pela parte ré, indicou, após a ineficácia de outros tratamentos, o uso, em caráter de urgência, pelo risco de agravamento das doenças e morte, do medicamento o Nintedanibe (OFEV) 150mg.

A negativa de fornecimento de tratamento na via administrativa lastreou-se na ausência de cobertura contratual para o fornecimento de medicamentos, o que, como visto, é manifestamente ilegal, à vista interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça à Lei nº 9.56/1998.

Acresço que o Tribunal de Justiça, em todas as oportunidades em que instado a decidir casos semelhantes ao dos autos, manifestou-se pelo dever de a UNIMED fornecer medicamentos para o tratamento fibrose pulmonar idiopática. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PIRFENIDONA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO.

1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998.

2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10.

3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO.

4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO.

5. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, SENDO INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, ASSIM COMO QUE A PARTE AUTORA CUMPRIU TODAS AS CARÊNCIAS CONTRATUALMENTE EXIGIDAS, BEM COMO HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO POSTULADO NA EXORDIAL (PIRFENIDONA), TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DA ALUDIDA MEDICAÇÃO, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO DE PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE (FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA), SENDO IRRELEVANTE, NO CASO, O LOCAL ONDE SERÁ MINISTRADO O FÁRMACO. DESTARTE, AFIGURA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DO DEVER DE COBERTURA.

6. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

APELO DESPROVIDO.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 5048896-63.2019.8.21.0001, RELATOR(A) DESEMBARGADORA LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA, ***QUINTA CÂMARA CÍVEL****, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JULGADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, APELANTE: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA; APELADO: MARIO TEIXEIRA DE ARAUJO)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS.

1. OS PLANOS OU SEGUROS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ENQUANTO RELAÇÃO DE CONSUMO ATINENTE AO MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ISTO É O QUE SE EXTRAI DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 35 DA LEI 9.656/98. SÚMULA N. 469 DO STJ.

2. A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E HOUVER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

3. NO CASO EM EXAME, ESTÁ PRESENTE O PERIGO DE DANO À SAÚDE DA PARTE AUTORA, QUE APRESENTA DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, NECESSITANDO REALIZAR TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO INDICADO A FIM DE REDUZIR A PROGRESSÃO DA DOENÇA E AUMENTAR O TEMPO DE VIDA DO PACIENTE.

4. AINDA, ESTÁ PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, TENDO EM VISTA QUE, EM TESE, O QUE IMPORTA PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA A PATOLOGIA APRESENTADA.

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

*(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011522-31.2020.8.21.7000, RELATOR(A) DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO**, QUINTA CÂMARA CÍVEL**, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JULGADO EM 24 DE JUNHO DE 2020, AGRAVANTE: UNIMED MISSOES - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDI; AGRAVADO: ATAIDES BONINI)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA PARA TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR COM O MEDICAMENTO 'NINTEDANIBE' (NOME COMERCIAL 'OFEV'). EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA.COBERTURA NÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA ABUSIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO

*(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017263-52.2020.8.21.7000, RELATOR(A) DESEMBARGADOR LUIS AUGUSTO COELHO BRAGA**, SEXTA CÂMARA CÍVEL**, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JULGADO EM 24 DE JUNHO DE 2020, AGRAVANTE: UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA; AGRAVADO: ANTOINETTE FRANCIS CHIDIAC)*

Isso posto, destaco que está demonstrado o perigo de dano, à saciedade, pois a não realização do tratamento acarretará a morte de JOSE ANTONIO FREITAS VALLE E SILVA PEZZI. Transcrevo o pormenorizado laudo médico que acompanhou a inicial:

Laudo Médico

O Sr Jose Antonio Freitas Valle e Silva Pezzi iniciou há 3 anos com sintomas de falta de ar aos esforços e foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática , CID 10: J84,1 e doença pulmonar obstrutiva crônica (CIDJ44). A fibrose pulmonar é uma doença grave, de caráter evolutivo e progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse. Necessita iniciar tratamento urgente, imediato e contínuo com a medicação antifibrótica Nintedanib 150mg 12/12h, havendo evidência científica para o tratamento, atualmente autorizado para uso no Brasil, com prazo de uso indeterminado. A fibrose pulmonar não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento. No teste de espirometria deste paciente identifica-se aspectos de doença obstrutiva crônica decorrentes do tabagismo, no entanto para esta patologia está devidamente medicado, com tratamento otimizado, em uso contínuo de dupla broncodilatação com anticolinérgico e beta adrenérgico de ação prolongada.

Ocorre que no período de acompanhamento entre 2017 e 2020 verificou-se a progressão dos achados de fibrose pulmonar na cortical de ambos pulmões, com definido faveolamento. Em decorrência da piora verificada clinicamente e radiologicamente necessitamos iniciar com urgência a medicação antifibrótica. No presente caso, não há exposição ambiental ou ocupacional, medicamento ou doença autoimune que determine doença fibrosante no paciente. Tem provas para doenças autoimunes não reagentes. O uso deste medicamento é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar idiopática com objetivo de evitar progressão da doença, perda progressiva da capacidade vital forçada e incremento dos sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias . Tal fármaco não pode ser substituído por nenhum outro disponível no SUS. Caso o paciente não use o medicamento , corre o risco de agravamento da doença e risco de morte por insuficiência respiratória.

Defiro, pois, a tutela de urgência postulada na inicial, determinando o fornecimento do tratamento indicado pelo médico assistente, no prazo de cinco dias.

Caso esta decisão não seja cumprida, procederei ao bloqueio em contas de titularidade da parte ré, no valor suficiente para o custeio de um ano de tratamento - R$ 262.345,08.

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Dispõe o artigo 334 do Código de Processo de 2015 que, recebida a inicial, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação.

Considerando, todavia, a emergência de saúde pública provocada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), postergo a realização desse ato processual.

AO CARTÓRIO:

- cite-se e intimem-se com urgência;

- noticiado pela parte autora o descumprimento desta decisão, retornem os autos conclusos, dentre os urgentes (localizador eproc/escaninho virtual CLAUDIO).

Na contestação, a parte ré impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, defendeu a higidez da cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Referiu que o medicamento pleiteado pela parte autora se destina a tratamento oncológico e não à doença da qual é acometida. Disse, ainda, que o medicamento não encontra-se incluído no rol taxativo da ANS, corroborando o regular indeferimento do custeio na via administrativa. Postulou a improcedência do pedido.

A parte autora se manifestou sobre a contestação, refutando os argumentos da parte ré e reiterando os veiculados na inicial.

Na sequência, as partes postularam pelo julgamento antecipado do pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Do julgamento antecipado do pedido

A matéria controvertida no feito resolve-se à luz da prova já produzida.

Outrossim, não houve requerimentos probatórios pelas partes.

De rigor, portanto, o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 4º, 139, inciso II, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Do mérito

Da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor em relação às operadoras de plano de saúde

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, já afirmou que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, com exceção daqueles celebrados com entidades de autogestão, constituídas com o único objetivo de ofertar planos de saúde a um grupo fechado de beneficiários, sem possuir fins lucrativos.

Nesse sentido é o enunciado nº 608 da Súmula desse Tribunal Superior. Confira-se:

> *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*

Conquanto seja inaplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, estão elas submetidas à lei de regência dos planos e seguros privados de assistência à saúde e disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Do tratamento mínimo assegurado pelo plano de saúde

A Lei nº 9.656/1998 estabelece as coberturas mínimas a serem oferecidas aos segurados e beneficiários de planos de saúde, previstas nos artigos 10 e 12.

Essas coberturas mínimas podem ser ampliadas, segundo normas estabelecidas pela ANS, autarquia federal para garantia da assistência suplementar à saúde, por força da Lei nº 9.961/2000.

Do cotejo do disposto no artigo 10 da Lei nº 9.656/1998 e do artigo 2º da Resolução Normativa nº 439/2018 da ANS, tem-se presente que as garantias mínimas alcançam todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

Daí decorre a conclusão de que, embora seja lícita a limitação das doenças cobertas pelo plano de saúde (AgInt no AREsp n. 622.630/PE,Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe18/12/2017), é defeso a negativa de custeio do tratamento daquelas que não estejam expressamente excluídas no contrato.

A vedação de exclusão do tratamento recomendado alcança o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, ainda que excepcionadas das garantias mínimas elencadas na legislação, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, combinado com o artigo 20, § 1º, inciso IV, da Resolução da ANS nº 428/2017.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).

Sobre o tema, decidiu a Relatora Ministra Nancy Andrighi ser abusiva até mesmo *a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato*. (AgInt no AREsp 1.573.008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

Porque representativa desse entendimento, colaciono a seguinte ementa:

> *EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO. ANVISA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. AFASTAMENTO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. NORMAS PROIBITIVAS DO SETOR. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LICENÇA POSTERIOR. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DEVIDA.*
>
> *1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se o plano de saúde deve arcar com os custos de medicamento importado sem registro na ANVISA, essencial para o êxito de tratamento oncológico (no caso, o Revlimid, para tratar mieloma múltiplo).*
> *[...]*
> *6. Após o ato registral, a operadora de plano de saúde não pode recusar o tratamento com o fármaco indicado pelo médico assistente.*
> *Com efeito, a exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e 7º, parágrafo único, e 17 da RN nº 387/2015 da ANS). Precedentes.*
> *7. Embargos de divergência rejeitados.*
> *(EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)*

Não obstante esse posicionamento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente assentou não ser meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde da ANS, a fim de preservar a viabilidade da saúde suplementar.

Assim, na hipótese de ausência do tratamento no contrato ou no rol da ANS, o seu custeio reclamaria a demonstração da sua necessidade, por meio de prova técnica.

Isso porque os procedimentos previstos no rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde editados pela ANS seriam suficientes a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas.

Nesse sentido, é o julgado abaixo ementado:

> *PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO*

(OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.
2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.
3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.
4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.
6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.
7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)

Filio-me ao entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, porque em que de adesão o contrato celebrado entre as partes, de modo que devem ser interpretadas as cláusulas em favor da parte hipossuficiente, presente o disposto no artigo 423 do Código Civil e no artigo 47 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Com efeito, não se pode admitir que a parte aderente ao plano de saúde seja submetida à sorte de o tratamento prescrito por seu médico assistente conste em rol genérico editado por outrem, que desconsidera as suas particularidades clínicas, para lograr a cobertura de custeio.

Ademais, é o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA. COBERTURA DEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Com efeito, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos do posicionamento jurídico adotado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Devem ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé, nos termos dos art. 421 e 422, ambos do Código Civil. Ademais, o Código Civil determina que nos contratos de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 423 do diploma citado. 3. Aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência de que tratam os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. 4. O rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. 5. Não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha. 6. O que importa para a solução do litígio é a existência de cobertura para a patologia apresentada, não o tipo de tratamento que será realizado. 7. Verba honorária mantida, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, nos termos do art. 85, § 8º do novel CPC. 8. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Negado provimento aos apelos.
(Apelação Cível, Nº 70083348144, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES NO CASO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1. A matéria discutida é preponderantemente de direito, estando acostada aos autos documentação suficiente ao deslinde do litígio. Ademais, a produção de provas se destina ao convencimento do magistrado, devendo este atender aos princípios da celeridade e economia processual. Inteligência do art. 370 do novel CPC. 2. Apesar da dispensa do medicamento postulado, com a substituição da medicação pelo médico assistente, tendo havido antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se necessário o julgamento do mérito, a fim de confirmar ou não os seus efeitos, não havendo que se falar em perda do objeto do feito. 3. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 4. Aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência de que trata os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. 5. O rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. O tratamento quimioterápico postulado pela parte autora foi indicado pelo médico que a acompanha, não havendo que se falar em preenchimento das diretrizes de utilização do procedimento. 6. Não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha. 7. A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, uma vez que a negativa do apelante não se pautou em determinação contratual. Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 8. O descumprimento do contrato, sem razão jurídica plausível, ou mesmo o atendimento do pacto de forma negligente, sequer atentando para a garantia dada e o bem a ser preservado, importa no dever de reparar o mal causado. 9. A demandada deve ressarcir os danos morais reconhecidos, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou no caso em tela. 10. A parte autora deixou de trazer aos autos qualquer documento que comprove tanto o alegado descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, quanto à alegação de que houve a substituição do fármaco em razão da demora no seu fornecimento, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. 11. Cuidando-se de ação que objetiva obrigação de fazer, o proveito econômico deve ser estimado, devendo ser adotada a quantia correspondente ao pedido de indenização por danos morais como valor da causa. À unanimidade, afastadas as preliminares suscitadas, negado provimento ao apelo da ré e dado parcial provimento ao recurso do autor, vencida a desembargadora Lusmary Fatima Turelly da Silva quanto ao termo inicial dos juros de mora.(Apelação Cível, Nº 70082866898, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 13-12-2019)

Portanto, sendo necessário o tratamento contínuo à manutenção da saúde do beneficiário ou dependente, deve o plano arcar com o seu custeio. Exemplificativamente, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1886488 - SP (2020/0188882-9) [...]
Preliminarmente, importante consignar que o acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
A irresignação não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem entendeu pela obrigatoriedade de fornecimento do medicamento de uso domiciliar pela operadora do plano de saúde, com base nos seguintes fundamentos:
"(...)
Em que pesem as ponderações da ré, não há de se falar em ausência de cobertura contratual, pois a doença que acomete a autora é abarcada pelo contrato, remanescendo dúvida apenas acerca da forma de tratamento, se mostrando descabida a negativa de custeio.
Aliás, a negativa emanada da ré se mostra flagrantemente abusiva, nos termos do art. 51, IV1, CDC, ao tentar obstar o tratamento de doença coberta pelo contrato, cuja falta de tratamento adequado não só prejudica a sobrevivência da autora, como pode ocasionar seu óbito.
Também não merece guarida a alegação de inexistência de obrigatoriedade de custeio do tratamento, por não constar do rol da ANS - responsável por disciplinar a cobertura mínima a ser oferecida pelas empresas de saúde pois tal circunstância não só impediria a consumidora de ter acesso às inovações oferecidas pela Medicina - já que por vezes a normatização não consegue acompanhar de perto os avanços tecnológicos como lhe tolheria a possibilidade de obter tratamento médico adequado e digno, indo de encontro com o objetivo do contrato celebrado entre as partes, circunstância reputada inadmissível.
Ademais, a negativa de cobertura de procedimento não elencado no rol da ANS já restou apreciada e sumulada por esta Corte (Súmula 1022 do TJSP), sendo considerada abusiva.
Oportuno ressaltar que não se trata de garantir cobertura irrestrita à consumidora, ou mesmo de conferir direitos além dos avençados, mas sim de garantir-lhe o tratamento necessitado, sobretudo em observância ao direito constitucionalmente garantido a uma vida digna, além de assegurar seu acesso aos avanços da medicina.
Além disso, compete ao profissional qualificado a indicação do tratamento mais adequado ao paciente, incluindo os exames e tratamentos solicitados, e não à operadora de saúde.
Descabida a alegação de ausência de cobertura para tratamento domiciliar, porquanto se trata de doença crônica, que demanda tratamento médico contínuo, e não de uma enfermidade pontual que requer o uso de um medicamento esporádico no ambiente doméstico.
Neste sentido, oportuno reforçar que se trata de uma doença coberta pelo contrato celebrado entre as partes, de modo que beira à má-fé a pretensão de submeter a beneficiária a um tratamento penoso e indigno, capaz de ocasionar sua morte, em detrimento de tratamento adequado, disponível e que deve ser fornecido pela ré. Aliás, quanto ao tema, assim já se decidiu:
(...)" (fls. 243/244, e-STJ).
Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que para uso domiciliar.
Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir sobre o tratamento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.
Assim, ainda que admitida a possibilidade de conter o contrato de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.
[...]
Nesse contexto, a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante desta Corte atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12,5% (doze e meio por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
Publique-se.

Intimem-se.
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 12/11/2020)

Fixadas essas premissas, AO EXAME DO CASO:

- é incontroversa a relação contratual entre as partes;

- a parte autora comprovou a necessidade do tratamento da doença que padece, consistente no medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, sob pena de progressão da moléstia, com risco de morte;

- demonstrou a parte autora a inexistência de tratamento alternativo ao prescrito pelo médico assistente;

- houve a negativa de cobertura ao custeio do tratamento de que necessita a parte autora na via administrativa;

- o tratamento recomentado pelo médico assistente da parte autora é de uso domiciliar;

- o tratamento domiciliar não afasta a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde, sendo irrelevante se consta, ou não, no rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde editados pela ANS, porque exemplificativo;

- a negativa foi ilícita;

Sendo esse o contexto, impõe-se a condenação da parte ré ao custeio do tratamento de que necessita a parte autora, enquanto se fizer necessário.

Do valor da causa

Nos termos do artigo 292, § 2º do Código de Processo Civil de 2015, o *valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.*

No caso, postula a parte autora o custeio de tratamento de doença da qual é acometida, por tempo indeterminado, atribuindo o valor da causa correspondente a soma de um ano de tratamento, com base no menor orçamento encontrado.

Por conseguinte, não há falar em incorreção do valor da causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, **julgo procedente o pedido**, nos seguintes termos:

- confirmo a tutela de urgência concedida, determinando-se o fornecimento à parte autora do tratamento da doença que padece - **fibrose pulmonar idiopática CID 10 J84. 1 e doença pulmonar obstrutiva crônica CID J44**, consistente no medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, uma cápsula de 12 em 12h, enquanto se fizer necessário.

A parte ré arcará com a integralidade das despesas processuais em sentido amplo ([…] as despesas judiciais são o gênero em que se inserem as custas judiciais, os honorários advocatícios, as multas porventura impostas, as indenizações de viagens, as diárias de testemunhas e as remunerações de peritos e de assistentes técnicos - ARENHARDT, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015), arbitrados os honorários dos patronos da parte autora em 15% do valor atribuído à

causa, tendo em vista o tempo de tramitação, o grau de complexidade da causa e a boa qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais, tudo de acordo com o disposto nos artigos 85, § 2°, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

O valor dos honorários deverá ser corrigido, pelo IGP-M (admitida a deflação, preservando-se, porém, o valor nominal), desde o ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora, no patamar de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil de 2015, vedada a capitalização

DO ANDAMENTO:

1) intimem-se as partes;

2) após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO AVIOTTI VIEGAS, Juiz de Direito**, em 22/9/2021, às 19:32:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10010658400v5** e o código CRC **d176d5d5**.